EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 66739
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2023-06-30 15:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JEANNETTE FRANCISCA SEPULVEDA ALARCON			RUN	: 14.304.265-0
F.Nac	: 04-10-1971	Edad	: 51 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 07-06-2023	Fecha Egreso	: 2023-06-30 15:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R17.X-ICTERICIA NO ESPECIFICADA.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnóstico:
- Masa perihiliar hepàtica en estudio
• Colangiocarcinoma Vs primario vesicular

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. C22-TUMOR MALIGNO DEL HIGADO Y DE LAS VIAS BILIARES INTRAHEPATIC (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente derivada al servicio de urgencias de nuestro centro por cuadro de ictericia de 2 semanas de evolución, asociado a nauseas, dolor abdominal y compromiso del estado general
A su llegada se constata paciente marcadamente icterica.
Se controla con exámenes de laboratorio que destacan hiperbilirrubinemia de predominio directo asociado a un perfil colestásico.
Se ingresa e inicia estudio
RNM Abdomen:
- Masa prominente de localización perihiliar que compromete los segmentos IV v y VIII de 92x72mm de aspecto neoplásico primario con dilatacion de VBIH.
- Adenopatías hiliares hepáticas y retroperitoneales secundarias de hasta 11mm
- Parcialmente se evidencian nódulos pulmonares pequeños y adenopatías epipericardicas.
- Concluye considerar colangiocarcinoma vs menos probable origen vesicular.

CA 125: 48.4, Ca19-9: 165, CEA: 3.17

En base a los hallazgos se decide la realización de una CPRE para prótesis biliar paliativa a la espera de evaluación por comité oncológico y definir con esto conducta terapéutica.
La paciente se a mantenido estable y en buenas condiciones, presentando leve dolor que responde a analgesia, sin nauseas ni vómitos. En base a esto se decide egreso a hospitalización domiciliaria para continuar manejo, a la espera de la CPRE.

PLAN DE MANEJO:

Analgesia
Mantener terapia antibiòtica
Egreso a hospitalización domiciliaria

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen liviano, hipograso
3. Metamizol 300 mg cada 8 horas vo por 5 días
4. Paracetamol 1 gr cada 8 horas vo por 5 dìas
5. Metronidazol 500 mg cada 8 horas vo por 10 dìas
6. Ceftriaxona 2 gr ev día por 10 días
7. Omeprazol 20 mg vo día por 10 días
8. Clorfenamina 4 mg cada 8 horas vo por 10 días
9. Reingreso para CPRE según disponibilida
10. Control en policlínico de cirugía en 2 semanas
11. Consultar en servicio de urgencias sos

EXÁMENES Y RESULTADOS

RNM Abdomen:
- Masa prominente de localización perihiliar que compromete los segmentos IV v y VIII de 92x72mm de aspecto neoplásico primario con dilatacion de VBIH.
- Adenopatías hiliares hepáticas y retroperitoneales secundarias de hasta 11mm
- Parcialmente se evidencian nódulos pulmonares pequeños y adenopatías epipericardicas.
- Concluye considerar colangiocarcinoma vs menos probable origen vesicular.

CA 125: 48.4, Ca19-9: 165, CEA: 3.17

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

PATRICIO ALEXIS JARA VILLA
MEDICO TRATANTE
17346122-4

JEFE SERVICIO